



• GUIA PARA PROFISSIONAIS

Protocolo de **Melasma** **e manchas**

Fitzpatrick e
**como diferenciar cada
mancha**

Com **ficha de
avaliação** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



PARTE 1 · FOTOTIPO E DIAGNÓSTICO

Fitzpatrick e qual mancha é essa

O fototipo é constitucional: nasce com a pessoa e se define pela **reação ao sol** (quanto queima e quanto bronzeia), não só pela cor da pele. Ele orienta o risco de mancha pós-procedimento e a escolha da conduta.

Tipo	Características típicas	Reação ao sol	No consultório
I	Pele muito clara, olhos azuis ou verdes, cabelo loiro ou ruivo	Sempre queima, não bronzeia	Mais efélides e lentigos
II	Pele clara, olhos azuis	Queima fácil, bronzeia pouco	Lentigo solar comum
III	Pele branca mais escura	Bronzeia depois de queimar	Faixa onde o melasma é mais frequente
IV	Pele morena clara	Queima pouco, bronzeia fácil	
V	Pele morena	Raramente queima, bronzeia escuro	Maior risco de hiperpigmentação pós-inflamatória
VI	Pele marrom-escura ou negra	Nunca queima, sempre bronzeia escuro	

Quem usa medicamento fotossensibilizante pode queimar com facilidade, mas a capacidade de bronzear não muda. Pergunte pelo histórico de sol sem a medicação.

Diferencie antes de tratar

Mancha	Como costuma aparecer	Pista que diferencia
Melasma	Manchas castanhas, bordas irregulares, simétricas, em áreas expostas do rosto (testa, malar, lábio superior, queixo)	Adulta jovem, piora com sol, gravidez ou hormônio; crônico e com recidiva
Hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI)	Castanha, rosada ou avermelhada, distribuição irregular	Fica exatamente onde houve acne, dermatite, queimadura ou procedimento
Lentigo solar	Lesão plana bem delimitada, cor uniforme, em dorso das mãos, antebraços e rosto	Adulto mais velho com dano solar acumulado; não some no inverno
Efélides (sardas)	Pequenas (3 a 10 mm), numerosas, nariz e bochechas	Desde a infância, fototipo baixo; escurecem no verão e clareiam no inverno

Outros diagnósticos que imitam melasma: nevo de Hori (azul-acinzentado ao redor dos olhos), ocronose exógena (manchas azuladas ou negras após uso de hidroquinona), melanose de Riehl (dermatite de contato com cosméticos) e doença de Addison (pigmentação difusa, com mucosas).



Por que o melasma volta

Melasma não é só melanócito trabalhando demais. A pele afetada tem alterações na epiderme, na membrana basal e na derme superior que mantêm o estímulo ligado, por isso a doença é crônica e não tem cura definitiva.

1

Luz e calor

UVB, UVA e luz visível de onda curta estimulam a melanogênese. UVA e luz visível atravessam vidro de janela e para-brisa. Calor intenso no trabalho está associado a casos mais graves.

2

Derme alterada

Membrana basal danificada, mais vasos (VEGF), mastócitos liberando histamina e triptase, fibroblastos senescentes e elastose solar sinalizam para o melanócito.

3

Hormônio e genética

Gravidez, anticoncepcional e terapia hormonal são gatilhos conhecidos. A herança tem componente genético e o histórico familiar é frequente.

O que dizem os dados brasileiros

Achado	Valor
Melasma facial em mulheres de 20 a 60 anos da população geral (estudo brasileiro, 303 mulheres, 2024)	36,3%
Pacientes com familiares afetados (302 pacientes de ambulatório)	56,3%
Gatilho relatado: gravidez · sol intenso · anticoncepcional	36,4% · 27,2% · 16,2%
Idade média de início	27,5 anos

Como avaliar

- 1 Padrão.** Centrofacial (testa, bochechas, nariz, lábio superior, queixo; o mais comum), malar, mandibular ou extrafacial (braços e ombros, mais em idade avançada).
- 2 Lâmpada de Wood e dermatoscopia.** Melasma que se acentua na Wood tende a responder melhor ao tópico. A divisão clássica em epidérmico, dérmico e misto ajuda a prever resposta, mas estudos de histologia não confirmam essa separação: use como pista, não como verdade.
- 3 Gravidade pelo mMASI.** Versão modificada do MASI sem o item homogeneidade, que tinha a pior concordância entre avaliadores. A face é dividida em 4 regiões e cada uma recebe nota de área (A) e de escurecimento (D):

Região	Fator	Área (A)	Escurecimento (D)
Testa	0,3	0 = sem mancha · 1 = <10% · 2 = 10–29% · 3 = 30–49% · 4 = 50–69% · 5 = 70–89% · 6 = 90–100%	0 ausente · 1 leve · 2 moderado · 3 acentuado · 4 máximo
Malar direita	0,3		
Malar esquerda	0,3		
Queixo	0,1		

Conta: soma de fator × A × D das 4 regiões. Vai de 0 a 24 (cálculo da ITH a partir das notas máximas). O consenso latino-americano de 2025 chama de **leve** o mMASI até 5 e de **moderado a grave** acima de 5.

Os pilares, segundo o consenso

O consenso latino-americano de 2025 (9 dermatologistas, método Delphi, com participação brasileira) organiza o manejo em fotoproteção, tópicos, medicação oral e procedimentos. Fotoproteção e tópico entram em todos os casos.

1. Fotoproteção com cor

Protetor de amplo espectro **com cor (óxido de ferro)** para cobrir a luz visível. Revisão brasileira sugere FPS 50 ou mais e PPD de 20 a 30, porque quase todo mundo aplica menos produto do que o teste usa. Reaplique e associe chapéu e sombra. Maquiagem não substitui o protetor por baixo.

2. Tirar o gatilho

Revise anticoncepcional, terapia hormonal, medicamentos fotossensibilizantes, cosméticos perfumados e calor no trabalho. Mudança de hormônio é decisão do médico assistente. O consenso recomenda envolver ginecologia, endocrinologia e saúde mental quando o caso pedir.

Despigmentantes tópicos citados no consenso

Ativo	Como atua	Cuidados
Hidroquinona (2 a 5% nos estudos)	Inibe tirosinase; referência de eficácia	Medicamento: no Brasil é proibida em cosméticos (RDC 529/2021). Uso por tempo limitado, risco de ocronose. Não usar na gravidez
Creme triplo	Hidroquinona + tretinoína + corticoide	Prescrição médica, uso intermitente. Não usar na gravidez nem na amamentação
Ácido azelaico (20%)	Inibe tirosinase	Ardência passageira; compatível com gestação segundo a revisão brasileira
Niacinamida (4 a 5%)	Reduz transferência de melanossomos; reforça barreira	Bem tolerada; compatível com gestação
Tiamidol, ácido kójico, arbutin, ácido tranexâmico tópico, ácido glicólico	Inibem tirosinase ou aceleram renovação	Irritação e dermatite de contato; glicólico pode gerar HPI em pele escura

Ácido tranexâmico oral é prescrição médica. A bula registrada na Anvisa indica o remédio para sangramentos: no melasma o uso é *off-label*. Os estudos usam 250 mg duas vezes ao dia por 2 a 4 meses. Ele é contraindicado em quem tem histórico pessoal ou familiar de trombose, doença cardiovascular, uso de anticoagulante, gravidez, entre outros. Ao parar, a mancha costuma voltar. Seu papel é identificar o caso e encaminhar.

Procedimentos: cautela por fototipo

- ✓ **Peelings superficiais seriados** (glicólico, salicílico, Jessner, retinoico) são adjuvantes. O consenso pede evitar peelings médios. O maior risco é a HPI em fototipos altos.
- ✓ **Microagulhamento** tem baixo risco de recidiva e pode ser feito em pele escura, sempre associado ao tópico e à fotoproteção.
- ✓ **Laser e luz** exigem cuidado máximo: o calor estimula melanogênese e pode piorar o quadro. O laser de corante pulsado não deve ser usado em fototipo IV ou acima.

Caso aplicado e ficha de avaliação

CÁLCULO RESOLVIDO

Paciente fictícia: 32 anos, fototipo IV, melasma centrofacial depois da gravidez, usa anticoncepcional

Testa: $0,3 \times A 2 \times D 2 = 1,2$

Malar direita: $0,3 \times A 3 \times D 2 = 1,8$

Malar esquerda: $0,3 \times A 3 \times D 3 = 2,7$

Queixo: $0,1 \times A 1 \times D 1 = 0,1$

mMASI inicial = **5,8**: acima de 5, moderado a grave no consenso

Meta da reavaliação em 6 a 8 semanas: queda de 30% ou mais = mMASI até **4,1**

Plano: protetor com cor, despigmentante tópico e encaminhamento ao dermatologista, porque no grupo moderado a grave o consenso considera medicação oral. Atingida a meta, mantém até a resposta máxima e passa para manutenção (tópico contínuo e fotoproteção). Abaixo de 30%, o caso é reavaliado.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha de avaliação de manchas

Item	Registro
Fototipo (I a VI) e reação ao sol	
Tipo de mancha: melasma · HPI · lentigo · efélide · outra	
Padrão e Wood: centrofacial · malar · mandibular · extrafacial	
Gatilhos: gravidez · hormônio · sol/calor · medicamento · cosmético · família	
mMASI inicial e data · reavaliação (6 a 8 semanas)	
Fotos: frente e dois perfis, mesma luz e distância, sem maquiagem	
Plano: fotoproteção · tópico · procedimento · encaminhamento	

Encaminhe ao dermatologista quando houver dúvida no diagnóstico, lesão que muda de forma, cor ou tamanho (lentigo pode esconder melanoma in situ), suspeita de ocronose, nevo de Horí ou Addison, indicação de medicação oral ou falta de resposta. **Antes de qualquer procedimento**, confira o que a resolução vigente do seu conselho permite; para esteticistas, a Lei 13.643/2018 prevê produtos e equipamentos com registro na Anvisa e não inclui estética médica.

● FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A faixa total do mMASI (0 a 24), o caso aplicado e a meta de reavaliação foram calculados pela ITH a partir dessas fontes. Tabelas resumidas com nossas palavras.

- 01 **Ocampo-Candiani J, Miot HA et al. Latin American consensus on the treatment of melasma. Int J Dermatol 2025;64:499-512**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11840225
- 02 **Cassiano DP et al. Update on Melasma, Part II: Treatment. Dermatol Ther 2022;12:1989-2012**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9464276
- 03 **Espósito ACC et al. Update on Melasma, Part I: Pathogenesis. Dermatol Ther 2022;12:1967-1988**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9464278
- 04 **Handel AC, Miot LDB, Miot HA. Melasma: a clinical and epidemiological review. An Bras Dermatol 2014;89(5):771-82**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155956
- 05 **Pandya AG et al. Reliability assessment and validation of the MASI and a new modified MASI. J Am Acad Dermatol 2011**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20398960
- 06 **Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol 1988**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3377516
- 07 **DermNet: Skin phototype (classificação de Fitzpatrick)**
dermnetnz.org/topics/skin-phototype
- 08 **DermNet: Melasma; Postinflammatory hyperpigmentation; Solar lentigo; Ephelis**
dermnetnz.org/topics/melasma
- 09 **Bula do ácido tranexâmico 250 mg (EMS), registro Anvisa: indicações e venda sob prescrição médica**
consultaremedios.com.br/acido-tranexamico-ems/bula
- 10 **Gomes AS et al. Rotulagem de cosméticos clareadores (hidroquinona e tretinoína proibidas pela RDC 529/2021). Rev Inst Adolfo Lutz 2023;82:e39330**
periodicos.saude.sp.gov.br/RIAL/article/view/39330
- 11 **Lei nº 13.643/2018 (profissões de esteticista e técnico em estética)**
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13643.htm

Ressalvas. Concentrações e doses citadas são as usadas nos estudos e não substituem prescrição. A classificação de Fitzpatrick descreve a reação da pele ao sol, não a etnia. O que cada profissional pode fazer depende da resolução vigente do seu conselho de classe.

• PARA IR ALÉM

Quer tratar mancha com segurança e método?

Melasma pede avaliação, protocolo e acompanhamento, e é na prática supervisionada que isso vira rotina. A Pós em Saúde Estética Avançada da ITH reúne facial, corporal e capilar, com várias vivências clínicas em pacientes modelo e mais de 30 técnicas.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ Várias vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

36,3%

das mulheres de 20 a 60 anos com melasma facial em estudo brasileiro

III e IV

fototipos em que o melasma é mais frequente

mMASI > 5

melasma moderado a grave pelo consenso de 2025

6 a 8 sem.

para reavaliar, com meta de queda de 30%